VADEMECUM

# Psicologo Digitale

## La stanza d'ascolto · guida tascabile

Colloquio preliminare con Neura, 6 questionari di autovalutazione, percorso in 8 tappe, 12 esercizi guidati e relazione per il professionista. Anche senza connessione, senza account e senza che nulla esca dal dispositivo.

Ideato, scritto e sviluppato da **Danilo D'Auria**
un progetto **FeniceOS**

Versione 1.3.27 · https://danilodauria.github.io/psicologo-digitale/
Codice MIT · Contenuti CC BY-NC-SA 4.0

**Questo programma è educativo e di orientamento.** Non formula diagnosi, non prescrive terapie e non sostituisce uno psicologo, uno psicoterapeuta o un medico. In caso di emergenza chiama il **112**.

## Indice

Le pagine che seguono sono pensate per essere stampate e tenute accanto al computer, oppure lette sul telefono. Ogni sezione si chiude con quello che conviene portare a un professionista.

Che cos'è e che cosa non è 3

In dieci minuti 4

I questionari 5

Il percorso in 8 tappe 6

Segnali d'allarme e numeri utili 8

Nutrizione e umore 9

Installala e usala offline 11

Privacy, backup, licenze 12

Da portare al professionista 12

# Che cos'è e che cosa non è

Psicologo Digitale è una **pre-analisi guidata**: serve a mettere in ordine ciò che senti prima di parlarne con qualcuno, a misurare l'intensità di alcune aree e ad arrivare al primo colloquio con parole più precise. Non è una terapia, non è una diagnosi e non è un test psicologico validato.

## Che cosa fa

- conduce un colloquio adattivo in 8 fasi (62 domande possibili);
- propone 6 questionari di autovalutazione con punteggi, fasce e lettura clinica;
- organizza un percorso in 8 tappe con 12 esercizi guidati;
- genera una relazione PDF da consegnare a chi può valutare davvero.

## Che cosa non fa

- non formula diagnosi e non sostituisce un professionista;
- non prescrive farmaci, dosi o terapie;
- non gestisce emergenze: per quelle c'è il 112;
- non invia nulla in rete: i dati restano nel browser del dispositivo.

**Una regola semplice.** Se ti accorgi di usare il programma per rimandare la telefonata a uno psicologo, hai già la risposta: quella telefonata è il passo successivo.

# In dieci minuti

Non serve completare tutto. Il modo più utile per iniziare è questo, e si può interrompere in qualsiasi momento: le risposte restano salvate sul dispositivo.

1. Leggi l'avvertenza e dai il consenso.
2. Fai il colloquio: rispondi di getto, senza cercare la risposta «giusta».
3. Compila uno o due questionari, quelli che riguardano l'area che ti pesa di più.
4. Guarda il quadro che emerge: aree, intensità, segnali da non ignorare.
5. Genera la relazione e portala con te, oppure scegli una tappa del percorso.

## Il colloquio, in pratica

Le fasi sono 8 e seguono un ordine preciso: prima si accoglie, poi si esplora il motivo, poi si approfondisce per area, si ricostruisce la storia, si guarda il funzionamento quotidiano, si controlla la sicurezza, si cercano le risorse e infine si restituisce una sintesi. Se una domanda ti mette a disagio, puoi saltarla: non è un esame.

| Fase | Che cosa esplora |
|---|---|
| 1 | Accoglienza |
| 2 | Motivo |
| 3 | Approfondimento |
| 4 | Storia |
| 5 | Funzionamento |
| 6 | Sicurezza |
| 7 | Risorse e obiettivi |
| 8 | Restituzione |

# I questionari

Sono indicatori di intensità, non strumenti diagnostici: non hanno valore di test psicometrico validato e non definiscono chi sei. Servono a capire quanto un'area pesa, nelle ultime due settimane, e a dare al professionista un punto di partenza concreto.

| Questionario | Item | Punteggio max |
|---|---|---|
| Umore, interesse e piacere | 9 | 27 |
| Ansia, tensione e preoccupazione | 7 | 21 |
| Stress percepito | 10 | 40 |
| Sonno e recupero | 7 | 28 |
| Esaurimento e carico di lavoro | 8 | 32 |
| Benessere generale | 5 | 100 |

## A che cosa serve ciascuno

**Umore, interesse e piacere.** Esplora il tono dell'umore, l'interesse, l'energia e la fiducia in sé. È l'area che più spesso accompagna ansia, stress e cambiamenti di vita.

**Ansia, tensione e preoccupazione.** Distingue la preoccupazione fisiologica da quella che occupa la giornata, disturba il sonno e spinge a evitare situazioni.

**Stress percepito.** Misura quanto la vita ti sembra imprevedibile, fuori controllo o sovraccarica: un fattore che influenza sonno, umore e salute fisica.

**Sonno e recupero.** Il sonno è il primo segnale che cambia in ansia, umore basso e burnout. Migliorarlo spesso migliora tutto il resto.

**Esaurimento e carico di lavoro.** Il burnout non è una malattia ma un fenomeno legato al lavoro: esaurimento, distacco mentale ed efficacia ridotta. Riconoscerlo presto cambia le scelte possibili.

**Benessere generale.** Non misura solo i sintomi: guarda a vitalità, interesse e piacere. Serve a bilanciare il quadro e a vedere le risorse, non solo le difficoltà.

**Attenzione.** Se un questionario contiene una domanda sui pensieri di morte e la risposta è affermativa, il programma mostra subito i numeri utili. Non è un eccesso di prudenza: è la parte più importante di tutto il percorso.

# Il percorso in 8 tappe

Circa sedici settimane, con una pratica settimanale e un indicatore per capire se sta funzionando. Non è obbligatorio seguirlo in ordine: scegli la tappa che corrisponde al tuo momento.

| Tappa | Titolo | Obiettivo |
|---|---|---|
| 1 | Orientarsi | Passare dal «sto male» a una descrizione condivisa: che cosa succede, da quando, quanto interferisce, che cosa lo mantiene. |
| 2 | Ritrovare il corpo | Ridurre l'attivazione fisiologica e ristabilire le condizioni di base: sonno, luce, movimento, caffeina. |
| 3 | Ricominciare a fare | Rompere il circolo «non ho voglia → non faccio → sto peggio» con azioni piccole, programmate e realistiche. |
| 4 | Guardare i pensieri | Distinguere fatti e interpretazioni, riconoscere le distorsioni e costruire letture più accurate. |
| 5 | Reggere le emozioni | Aumentare la capacità di stare con emozioni intense senza evitarle e senza esserne travolti. |
| 6 | Confini e relazioni | Esprimere bisogni e limiti in modo chiaro, riducendo conflitti inutili e senso di colpa. |
| 7 | Direzione e valori | Collegare le azioni quotidiane a ciò che conta, per sostenere la motivazione oltre il sintomo. |
| 8 | Consolidare | Riconoscere i segnali precoci, avere un piano scritto e sapere quando chiedere aiuto. |

## Gli esercizi

Sono pratiche brevi, da fare quando servono e non per dovere. Se un esercizio ti fa stare peggio, smetti e parlane con il professionista: anche le tecniche hanno controindicazioni.

| Esercizio | Durata | Quando |
|---|---|---|
| Respiro lento 4-6 | 5 minuti | Prima di dormire, prima di una situazione temuta, quando senti il corpo in allarme. |
| Ancoraggio 5-4-3-2-1 | 5 minuti | Attacchi di panico, rimuginio intenso, sensazione di irrealtà. |
| Attivazione comportamentale | 10 minuti di pianificazione | Ritiro, apatia, giornate che si svuotano. |
| Scheda del pensiero | 15 minuti | Un pensiero ti ha fatto stare male e vuoi capirlo. |
| Finestra della preoccupazione | 10 minuti | Preoccupazioni che tornano durante il giorno o prima di dormire. |
| Sonno: le sei regole | 10 minuti | Insonnia lieve o sonno irregolare. |
| Pausa di autocompassione | 8 minuti | Dopo un errore, un rifiuto, una giornata in cui ti sei giudicato/a duramente. |
| Una conversazione difficile (DESC) | 15 minuti | Un conflitto che si ripete, un favore che pesa, un limite da mettere. |
| Bussola dei valori | 20 minuti | Confusione, mancanza di motivazione, sensazione di vivere per gli altri. |

| Esercizio | Durata | Quando |
|---|---|---|
| Rilassamento muscolare progressivo | 15 minuti | Tensione cronica, difficoltà a rilassarsi, prima di dormire. |
| Camminata consapevole | 15 minuti | Giornate sedentarie, testa piena, bisogno di staccare. |
| Piano di mantenimento | 20 minuti | Fine del percorso e ogni volta che ti senti più stabile. |

# Segnali d'allarme e numeri utili

Se c'è un pericolo immediato per la tua vita o per quella di un'altra persona, chiama il 112. Non aspettare di avere le parole giuste: il 112 risponde anche per emergenze psicologiche.

## Segnali da non ignorare

- Pensieri ricorrenti che sarebbe meglio non esserci, o di farsi del male.
- Un piano preciso, l'accesso a mezzi, o un tentativo già avvenuto.
- Sentirsi un peso per gli altri, isolarsi, regalare cose, salutare come se fosse un addio.
- Non dormire, non mangiare, non riuscire più a svolgere le attività di base per giorni.
- Sentire voci o credere cose che gli altri non vedono, con paura o disorganizzazione.
- Subire minacce, percosse, controllo o isolamento da parte di qualcuno.
- Bere o usare sostanze in modo che mette a rischio la propria sicurezza.
- Dolore al petto, fiato corto nuovo, svenimenti: valutazione medica urgente.

## Cosa fare subito

1. Se il pericolo è immediato: chiama il 112 e resta in linea. Se puoi, non restare solo/a.
2. Se pensi al suicidio: dillo a una persona di fiducia e a un professionista. Non è un segreto da custodire.
3. Allontana o fai allontanare i mezzi per farsi del male, se è possibile farlo in sicurezza.
4. Se subisci violenza: 1522. Se sei in pericolo immediato: 112. Esistono centri antiviolenza e case rifugio.
5. Se sei un minore: parla con un adulto di fiducia, chiama il 19696 o il 114.
6. Non usare alcol o sostanze per gestire la crisi: peggiorano il controllo degli impulsi.
7. Dopo una crisi, chiedi un appuntamento con il medico o con un professionista della salute mentale.

| Numero | Servizio | A che cosa serve |
|---|---|---|
| 112 | Emergenza unica europea | Da qualsiasi telefono, anche senza credito. Per pericolo immediato. |
| 02 2327 2327 | Telefono Amico Italia | Ascolto per chi attraversa un momento difficile. Tutti i giorni. |
| 06 77208977 | Samaritans Onlus | Ascolto per chi è in crisi o ha pensieri suicidari. Attivo tutti i giorni, 13-22. |
| 19696 | Telefono Azzurro | Bambini e adolescenti, 24 ore su 24. Anche chat sul sito. |
| 1522 | Numero antiviolenza e stalking | Gratuito, multilingue, 24 ore su 24. Anche chat e app. |
| 114 | Emergenza infanzia | Emergenze che coinvolgono minori. |

**In pericolo immediato: 112.** Non serve avere le parole giuste e non serve aspettare. Se il rischio riguarda un'altra persona, non lasciarla sola e aiutala a chiamare.

# Nutrizione e umore

Mangiare non è solo carburante: è sonno, energia, umore, digestione, relazioni e spesso anche il modo in cui ci prendiamo cura di noi. Questa sezione non ti dà una dieta e non ti dice cosa devi pesare. Serve a capire cosa conta davvero, quali domande portare a chi è competente e quando il cibo smette di essere un piacere e diventa una preoccupazione.

## Cinque cose che contano

**La regolarità conta più della perfezione.** Il corpo lavora meglio con orari stabili: colazione, pranzo, cena e, se serve, uno spuntino. Saltare i pasti per rimediare a un pasto abbondante è la mossa che più spesso peggiora fame, umore e sonno. Non esiste il pasto «sbagliato» da espiare.

**Il modello mediterraneo regge il confronto.** È uno dei modelli alimentari più studiati: verdure e frutta in abbondanza, legumi, cereali integrali, pesce, olio d'oliva, frutta secca; carne rossa e dolci con moderazione. Non è una moda: è una tradizione con alle spalle anni di osservazione.

**La fibra parla con l'intestino e con l'umore.** Legumi, cereali integrali, verdura e frutta nutrono la flora intestinale. Le indicazioni italiane parlano di circa 25 grammi al giorno per un adulto; la maggior parte delle persone ne mangia meno della metà. Si aumenta piano, bevendo di più.

**Caffeina e alcol si sentono sul sonno.** La caffeina resta in circolo per ore: un caffè alle 17 può pesare alle 23. L'alcol fa addormentare prima ma frammenta la seconda metà della notte, e il sonno perso si ripercuote su umore e fame del giorno dopo.

**Muoversi e vedere la luce del mattino.** Non è nutrizione, ma lavora sullo stesso sistema: una camminata e venti minuti di luce naturale al mattino aiutano ritmo sonno-veglia, appetito e tono dell'umore. Vale più di qualsiasi integratore.

## Chi consultare

| Figura | Quando serve |
|---|---|
| Dietista | Quando serve un piano concreto e un accompagnamento nel tempo, anche attraverso il servizio pubblico. |
| Dietologo | Quando c'è una malattia da gestire, un peso che mette a rischio la salute o più problemi insieme. |
| Biologo nutrizionista | Quando serve un percorso nutrizionale in studio privato, senza patologie mediche da trattare. |
| Medico di medicina generale | Sempre, come punto di partenza, e obbligatoriamente se ci sono sintomi fisici o farmaci in corso. |
| Psicologo o psicoterapeuta | Quando il cibo è diventato un modo per gestire emozioni, o quando è stato diagnosticato un disturbo alimentare. |

## Quando non aspettare

- Perdita o aumento di peso involontario, superiore al cinque per cento in un mese.
- Restringere sempre di più ciò che mangi, contare calorie o grammi in modo ossessivo, saltare pasti in modo ricorrente.
- Abbuffate con la sensazione di perdere il controllo e, dopo, vergogna o comportamenti di compenso.

- Vomito autoindotto, uso di lassativi o diuretici, esercizio fisico usato per «bruciare» ciò che hai mangiato.
- Paura intensa di ingrassare che condiziona scelte, uscite e relazioni.
- Il pensiero del cibo occupa gran parte della giornata e ti impedisce di fare altro.

**Se riconosci anche solo uno dei primi sei segnali, non aspettare: parlane con il medico di base o con un centro per i disturbi dell'alimentazione della tua azienda sanitaria. Non è un problema di volontà e non si risolve con forza di carattere. Per un malessere improvviso chiama il 112.**

# Installala e usala offline

Non c'è un negozio di applicazioni e non serve: è una PWA e si installa dal browser in pochi secondi. Dopo la prima apertura funziona anche senza connessione.

## Android (Chrome)

Menu ■ in alto a destra → **Installa app** (su alcuni telefoni **Aggiungi alla schermata Home**).

## iPhone e iPad (Safari)

Tocca **Condividi**, scorri e scegli **Aggiungi alla schermata Home**.

## Computer (Chrome o Edge)

L'icona di installazione compare nella barra degli indirizzi; in alternativa menu ■ → **App** → **Installa questo sito come app**. Su Safari per Mac: **File** → **Aggiungi al Dock**.

## La barra in alto

Sotto l'intestazione c'è una barra sempre visibile: dice se stai usando il browser, la PWA installata o il programma per computer, se Ollama risponde, se il microfono è pronto e come attivarlo, e offre **Ferma l'audio** e **Indietro**. In fondo alla barra, **Aiuto subito** mostra 112, 1522 e Telefono Azzurro: sono a un tocco da qualsiasi pagina.

## Un modello locale, se ti va

Neura funziona da sola. Se vuoi anche un modello generativo sul tuo computer puoi installare **Ollama**, gratuito e open source: la pagina *Installa* riconosce sistema e memoria, propone il pacchetto giusto e il modello adatto, e verifica il collegamento locale. Resta un extra: Neura non lo usa e le risposte verificate restano le sue.

| Modello | Spazio | Memoria |
|---|---|---|
| qwen2.5:1.5b | circa 1 GB | almeno 4 GB |
| llama3.2:3b | circa 2 GB | almeno 8 GB |
| qwen2.5:7b | circa 4,7 GB | almeno 16 GB |
| qwen2.5:14b | circa 9 GB | almeno 32 GB |

# Privacy, backup, licenze

Non c'è un account e non c'è un server. Risposte, questionari, diario e relazione restano nel *localStorage* del browser, su quel dispositivo. Nessuna telemetria, nessuna pubblicità, nessun dato inviato a terzi.

## Che cosa sapere

- se cancelli i dati del browser, i dati spariscono: esporta un backup JSON dalla sezione Licenze;
- la relazione PDF viene generata sul dispositivo e condividerla dipende solo da te;
- i dati sono sensibili: conserva il backup in un luogo protetto, non in una cartella condivisa.

## Licenze

Codice con licenza **MIT**. Contenuti, testi, questionari, esercizi e grafica con licenza **Creative Commons BY-NC-SA 4.0**: attribuzione, non commerciale, stessa licenza. «Psicologo Digitale» e «Neura» sono di Danilo D'Auria, un progetto FeniceOS.

## Fonti principali

- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) — https://www.psy.it/
- Ministero della Salute — https://www.salute.gov.it/
- Istituto Superiore di Sanità — https://www.iss.it/
- NICE — https://www.nice.org.uk/
- Organizzazione Mondiale della Sanità — https://www.who.int/
- DSM-5-TR — https://www.psychiatry.org/
- Telefono Amico Italia — https://www.telefonoamico.it/
- 1522 — https://www.1522.eu/
- Telefono Azzurro — https://azzurro.it/

# Da portare al professionista

- la relazione PDF stampata, con punteggi e aree emerse;
- le date e i momenti in cui il problema si è fatto sentire di più;
- i farmaci che prendi e le sostanze che usi, senza vergogna;
- le domande che ti sei scritto, anche quelle che sembrano banali;
- una persona di fiducia, se ti aiuta non andare da solo.

Vademecum di Psicologo Digitale · versione 1.3.27 · https://github.com/danilodauria/psicologo-digitale
Stampato o letto, questo opuscolo non sostituisce una valutazione professionale.